

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Biologia Celular, Embriologia E Genética
PPG Biologia Celular e do Desenvolvimento
Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE)

Pós-doutorando: Dr. Tiago Fernando Chaves

Supervisores: Profa Dra Yara Costa Netto Muniz & Daniel
Pacheco Bruschi



Case 1:

 Prontuário Clínico: Clark Kent

Identificação do Paciente

- **Nome:** Clark Kent
- **Data de Nascimento:** 05/03/2012
- **Idade:** 13 anos
- **Sexo:** Masculino
- **Cor:** Caucasiano
- **Registro:** PLANETA-DIARIO-2025-45678
- **Data da Anamnese:** 12/11/2025

História Clínica (HDA) - Queixa Principal e História de Doença Atual

Paciente encaminhado por queixas visuais e achados de múltiplas alterações sistêmicas.

Queixas Oftalmológicas: Desde os 6 anos, a família relata **baixa acuidade visual progressiva e dificuldade extrema para enxergar em ambientes com pouca luz** (nictalopia). Recentemente, Clark verbaliza sentir que sua **visão lateral (periférica) está se estreitando**, como se estivesse olhando através de um tubo.

Queixas Metabólicas/Nutricionais: Apresenta **obesidade de início precoce**, com ganho de peso acelerado a partir dos 5 anos, predominantemente no tronco (obesidade troncular), persistente apesar de esforços na dieta e atividade física.

Queixas do Desenvolvimento: Apresenta **dificuldades persistentes de aprendizagem** e desenvolvimento cognitivo considerado levemente aquém do esperado para a idade, necessitando de suporte pedagógico desde cedo.

Queixas Endócrinas: Atraso no início da puberdade. Nenhuma característica sexual secundária foi observada até o momento.

História Familiar (HF)

- **Pai Adotivo (Jonathan Kent):** 60 anos, saudável.
 - **Mãe Adotiva (Martha Kent):** 58 anos, saudável. Nega consanguinidade na família imediata.
 - **Histórico Secundário:** Martha Kent relata um **primo de sua avó** que, na velhice, tinha **problemas sérios de sobrepeso e perda de visão**, mas que a causa nunca foi bem estabelecida. O restante da família nuclear e extensa é aparentemente saudável.
-

Exame Físico

- **Estado Geral:** Regular, com alerta e orientado.
 - **Antropometria:** Altura: 155 cm (p25). Peso: 95 kg. IMC: $39,5 \text{ kg/m}^2$ (Obesidade de grau severo/mórbida).
 - **Membros:** Exame dos membros superior e inferior com **contagem normal de dedos (ausência de polidactilia)**. Presença de discreta incoordenação motora (ataxia leve).
 - **Genitália:** **Hipoplasia genital/Hipogonadismo** (Estágio Tanner G1 - pré-puberal, testículos pequenos para a idade).
 - **Neurológico:** Dificuldade sutil de coordenação e equilíbrio (marcha discretamente instável).
-

Exames Complementares (Resultados Chave)

- **Oftalmologia (Exame de 10/2025):**
 - **Fundoscopia:** Presença de **depósitos pigmentados periféricos em forma de "espículas ósseas"** e estreitamento dos vasos sanguíneos da retina (atenuação arteriolar). Achados compatíveis com **Distrofia Retiniana / Retinopatia Pigmentar (RP)**.
 - **Eletrorretinograma (ERG):** Respostas dos bastonetes ausentes e respostas dos cones muito reduzidas.
 - **Avaliação Renal:**
 - **Ultrassom Renal:** Morfologia e dimensões dos rins normais. **Ausência de anomalias renais estruturais evidentes**.
 - **Exames Bioquímicos:** Creatinina sérica e eletrólitos dentro da normalidade.
-

Impressão Clínica (Sintomatologia Múltipla)

Paciente jovem apresentando uma constelação de achados clínicos multissistêmicos:

1. Distrofia Retiniana Progressiva (Retinopatia Pigmentar).
2. Obesidade Troncular de Início Precoce.
3. Hipogonadismo.
4. Dificuldade de Aprendizagem/Déficit Cognitivo Leve.

Nota: A associação desses quatro achados sistêmicos sugere fortemente uma condição genética pleiotrópica subjacente, apesar da **ausência de polidactilia e anomalias renais estruturais graves**.

Plano de Conduta

1. **Investigação Etiológica:** Solicitar **Painel de Sequenciamento Genético** abrangente focado em doenças raras com fenótipos visuais, metabólicos e endócrinos combinados.
 2. **Multidisciplinaridade:** Iniciar acompanhamento com:
 - **Geneticista:** Para diagnóstico e aconselhamento familiar.
 - **Endocrinologista:** Para manejo da obesidade e investigação/tratamento do atraso puberal.
 - **Nefrologista:** Para monitoramento contínuo da função renal, mesmo com os exames iniciais normais.
 3. **Suporte Terapêutico:** Encaminhamento para especialistas em **baixa visão** e manutenção/intensificação do **suporte psicopedagógico**.
-